Клинические рекомендации

Краниальные мононейропатии у взрослых

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**B02.2** — Опоясывающий лишай с другими осложнениями со стороны нервной системы **G44.0** — Синдром «гистаминовой» головной боли **G50.0** — Невралгия тройничного нерва **G50.1** — Атипичная лицевая боль **G50.8** — Другие поражения тройничного нерва **G50.9** — Поражение тройничного нерва неуточненное **G51.0** — Паралич Белла **G51.1** — Воспаление узла коленца **G51.2** — Синдром Россолимо-Мелькерссона **G51.3** — Клонический гемифациальный спазм **G51.4** — Лицевая миокимия **G51.8** — Другие поражения лицевого нерва **G51.9** — Поражение лицевого нерва неуточненное **G52.0** — Поражения обонятельного нерва **G52.1** — Поражения языкоглоточного нерва **G52.2** — Поражения блуждающего нерва **G52.3** — Поражения подъязычного нерва **G52.7** — Множественные поражения черепных нервов **G52.8** — Поражения других уточненных черепных нервов **G52.9** — Поражение черепного нерва неуточненное **G53.0** — Невралгия после опоясывающего лишая (B02.2+) **G90.0** — Идиопатическая периферическая вегетативная невропатия
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 26.12.2024, пересмотр не позднее 2027 года
Разработчик	Ассоциация нейрохирургов России; Всероссийское общество неврологов; Общероссийская общественная организация "Союз реабилитологов России"; ООО «Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии»; Ассоциация специалистов по клинической нейрофизиологии; Некоммерческая организация «Ассоциация интервенционного лечения боли»
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/895_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения **4**

2. Клиническая картина и классификация **4**

2.1 Тройничный нерв: определения 4

2.2 Лицевой нерв: определения 5

2.3 Причины 5
2.4 Классификация 7
2.5 Клиническая картина: тригеминальная невралгия 7
2.6 Клиническая картина: тригеминальные автономные цефалгии 8
2.7 Клиническая картина: нейропатия лицевого нерва 9
2.8 Клиническая картина: гемифациальный спазм и миокимия 10
2.9 Клиническая картина: другие черепные нервы 11
3. Диагностика 11
3.1 Критерии диагноза 11
3.2 Жалобы и анамнез 12
3.3 Неврологический осмотр 13
3.4 Анализы крови 15
3.5 Магнитно-резонансная томография 16
3.6 КТ височной кости и другие лучевые исследования 17
3.7 Видеоларингоскопия 17
3.8 Ультразвуковое исследование 17
3.9 Электронейромиография и электромиография 18
3.10 Количественное сенсорное тестирование 18
3.11 Консультация оториноларинголога 19
3.12 Другие консультации 19
3.13 Направление к хирургу 20
4. Лечение 20
4.1 Тригеминальная невралгия: подходы 20
4.2 Тригеминальная невралгия: купирование приступа 22
4.3 Тригеминальная невралгия: хроническая боль 22
4.4 Тригеминальная невралгия: малоинвазивные вмешательства 23
4.5 Тригеминальная невралгия: операции 23
4.6 Атипичная лицевая боль: лекарства 23
4.7 Атипичная лицевая боль: психотерапия и вмешательства 24
4.8 Тригеминальная нейропатическая боль 24
4.9 Кластерная головная боль 25
4.10 Другие тригеминальные автономные цефалгии 26
4.11 Паралич Белла: лекарства 27
4.12 Нейропатия лицевого нерва: ботулинотерапия 27
4.13 Нейропатия лицевого нерва: операции 27
4.14 Гемифациальный спазм 29
4.15 Лицевая миокимия 29
4.16 Невралгия языкоглоточного нерва 29
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 30
5.1 Реабилитация при нейропатии лицевого нерва 30
5.2 Диспансерное наблюдение 31
5.3 Показания к госпитализации 31
5.4 Исход 32

6. Источник и актуальность 32
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 32

1. Основные положения

- Поражения тройничного нерва (невралгия, атипичная лицевая боль, нейропатическая боль, автономные цефалгии), лицевого нерва (нейропатия, гемифациальный спазм, миокимия) и других черепных нервов.
- Паралич Белла — диагноз исключения; развивается за 24–48 часов, максимум за 72 часа. Глюкокортикоиды — **как можно раньше, лучше в первые 72 часа**, при любой тяжести; при тяжёлой форме — вместе с противовирусными.
- Нейропатия лицевого нерва — всем оториноларинголог с отоскопией, по показаниям аудиометрия и тимпанометрия. Снижение слуха на стороне поражения нехарактерно — заподозрить объёмное образование.
- «Красные флаги» или симптомы **более 3 недель** — МРТ головного мозга с контрастом.
- Тяжёлая нейропатия (V–VI степень) — ЭНМГ **не ранее 8 суток**: М-ответ ниже на 90% и более — к хирургу. Электростимуляция и форсированные упражнения не рекомендуются.
- Экстренная госпитализация при нейропатии лицевого нерва показана в первые **72 часа** для внутривенного введения #метилпреднизолона в высокой дозе, а также при других неврологических симптомах, нарастании тяжести с нарушением сознания, лихорадкой, менингеальными симптомами, декомпенсации артериального давления или сахарного диабета, при беременности.
- Тригеминальная невралгия: препараты первой линии — карбамазепин и окскарбазепин.
- Невралгия языкоглоточного нерва — приступы боли по типу удара тока в задней части языка, миндалине, глотке, у угла челюсти, в ухе; обследование включает МРТ, УЗИ шеи и видеоларингоскопию.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Тройничный нерв: определения

Тригеминальная невралгия — односторонние повторяющиеся кратковременные приступы боли по типу удара током, внезапно начинающиеся и прекращающиеся, провоцируемые безболевыми раздражителями, в зоне одной или нескольких ветвей тройничного нерва. Может сопровождаться постоянной фоновой болью умеренной интенсивности.

Атипичная лицевая боль и нейропатическая боль

Состояние	Определение
Персистирующая идиопатическая лицевая боль	постоянная боль в лице, ежедневно **более 2 часов в день** **более 3 месяцев**, без выраженных неврологических нарушений и предшествующей причины
Миофасциальная орофациальная боль, связанная с мышечным спазмом	боль от внезапного непроизвольного обратимого тонического сокращения жевательной мышцы; возможно острое нарушение прикуса
Синдром пылающего рта	жжение или дизестезия в полости рта ежедневно **более 2 часов в день** **более 3 месяцев** без признаков основного заболевания
Тригеминальная нейропатическая боль	боль в зоне одной или нескольких ветвей тройничного нерва, вызванная другим заболеванием и указывающая на повреждение нерва

Тригеминальные автономные (вегетативные) цефалгии — первичные головные боли

1. **кластерная головная боль** — короткие односторонние атаки крайне сильной боли в области орбиты, подглазничной или височной области с вегетативными симптомами со стороны глаза и носа
2. **пароксизмальная гемикрания** — строго односторонняя боль в области орбиты, подглазничной или височной области по 2–30 минут, много раз в день, с вегетативными симптомами; купируется индометацином
3. **SUNCT** — короткие односторонние атаки боли в глазничной и окологлазничной области, всегда с инъекцией конъюнктивы и слезотечением
4. **SUNA** — то же, но инъекции конъюнктивы и слезотечения нет или есть только один из этих симптомов
5. **гемикрания континуа** — непрерывная односторонняя головная боль умеренной интенсивности с обострениями и вегетативными симптомами, абсолютный эффект индометацина

2.2 Лицевой нерв: определения

Нейропатия лицевого нерва — асимметрия лица из-за односторонней слабости мимических мышц (прозопарез — движения есть, прозоплегия — нет) с неполным закрытием глаза; симптомы по уровню поражения и поздние осложнения — ниже. Паралич Белла — идиопатическая форма.

Гемифациальный спазм — хронические пароксизмальные безболезненные непроизвольные односторонние тонические или клонические сокращения мышц лица, в том числе в покое и ночью.

Лицевая миокимия — спонтанные односторонние низкоамплитудные пульсирующие подёргивания одной мышцы лица (чаще нижней порции круговой мышцы глаза), от секунд до часов, реже до недель; заметнее пациенту, чем окружающим.

Краниальная невропатия — любое повреждение черепного нерва на любом уровне.

Уровни поражения лицевого нерва

1. мосто-мозжечковый угол;
2. внутренний слуховой проход;
3. костный канал до отхождения большого каменистого нерва;
4. костный канал до отхождения стремянного нерва;
5. выход через шилососцевидное отверстие;
6. околоушная железа;
7. отдельные ветви в мимических мышцах.

2.3 Причины

1. **Классическая тригеминальная невралгия** — нейроваскулярный конфликт — сдавление корешка сосудом, чаще верхней мозжечковой артерией
2. **Симптоматическая** — опухоль, артериовенозная мальформация, демиелинизация при рассеянном склерозе
3. **Идиопатическая** — причина неизвестна

Паралич Белла — диагноз исключения. Основные гипотезы — вирусная (реактивация HSV-1, HSV-2, VZV на фоне стресса, переохлаждения, другой инфекции) и аутоиммунная. Связан с осенью, перепадами температуры, сахарным диабетом.

1. **Синдром Рамсея Ханта** — герпетическое поражение коленчатого узла: прозопарез или прозоплегия на фоне боли и кожных высыпаний; у 50–85% тяжелее паралича Белла, склонен к рецидивам
2. **Синдром Россолимо — Мелькерссона** — генетическое заболевание: рецидивирующий прозопарез с отёком губ и складчатым языком
3. **Объёмные образования (8–12%)** — шванномы лицевого нерва, опухоли мосто-мозжечкового угла и околоушной железы
4. **Другие частые причины** — осложнения хирургических, косметологических и стоматологических вмешательств, черепно-мозговая травма, неврологические заболевания, инфекции, метаболические нарушения; реже — радиохирургия вестибулярной шванномы
5. **Боррелиоз** — изолированная нейропатия лицевого нерва у 34–56% — учитывать при дифференциальной диагностике

Гемифациальный спазм

1. **первичный** — сдавление корешка лицевого нерва сосудом, чаще передней нижней мозжечковой артерией
2. **вторичный** — опухоль мосто-мозжечкового угла или околоушной железы, сосудистые аномалии, аномалия Киари, инфекции сосцевидного отростка и уха (средний отит, холестеатома), травма, поражение ствола мозга, перенесённая нейропатия лицевого нерва (постпаралитический гемиспазм)
3. **провоцируют** — холод, яркий свет, стресс

Синкинезии — непроизвольное сокращение одной группы мышц (или работа железы) при произвольном сокращении другой. Чаще всего окуло-скуловая и окуло-оральная (более 90%), оро-окулярная (59%), «крокодиловы слёзы» — слезотечение при жевании. Несколько синкинезий вместе — постпаралитический гемиспазм.

Первичная миокимия — от физического или эмоционального перенапряжения, кофеина, проходит сама. Вторичная — побочный эффект препаратов (топирамат, габапентин), дебют рассеянного склероза, объёмного процесса ствола, вестибулярной шванномы, тиреотоксикоза.

Невралгия языкоглоточного нерва

1. **классическая** — нейроваскулярный конфликт
2. **вторичная** — травма шеи, рассеянный склероз, тонзиллярные или регионарные опухоли, опухоль мосто-мозжечкового угла, мальформация Арнольда — Киари
3. **идиопатическая** — причина не найдена

Поражения обонятельного нерва, нервов глазодвигательной и каудальной групп — проявления другого заболевания

1. нарушение мозгового кровообращения;
2. травма головы и шеи;
3. тромбоз венозных синусов;
4. воспалительные заболевания околоносовых пазух;
5. опухоли головы и шеи;
6. системные и метаболические заболевания;
7. миастения, боковой амиотрофический склероз;
8. сосудистые мальформации.

Тригеминальная нейропатическая боль — после травмы нерва, герпетической инфекции и других причин; постгерпетическая невралгия — реактивация Herpes zoster.

2.4 Классификация

Тригеминальная невралгия: классическая, идиопатическая, симптоматическая. По Burchiel: 1 тип — только типичные прострелы; 2 тип — ещё и постоянная фоновая боль.

Атипичная лицевая боль (ICOP)

1. синдром пылающего рта: без соматосенсорных изменений, с соматосенсорными изменениями, возможный;
2. персистирующая идиопатическая лицевая боль: без соматосенсорных изменений, с ними, возможная;
3. миофасциальная орофациальная боль, связанная с мышечным спазмом.

«Возможный» — те же признаки, но **менее 3 месяцев**.

Тригеминальная нейропатическая боль (ICOP)

1. связанная с Herpes zoster;
2. постгерпетическая невралгия;
3. посттравматическая (и возможная посттравматическая);
4. связанная с другим нарушением (и возможная);
5. идиопатическая.

Тригеминальные автономные цефалгии

1. **эпизодическая кластерная головная боль** — не менее 2 периодов **более 7 дней** в году, ремиссия **более 3 месяцев** (около 80% пациентов)
2. **хроническая кластерная головная боль** — приступы **1 год** без ремиссий или с ремиссиями **менее 3 месяцев**
3. **пароксизмальная гемикрания** — эпизодическая — атаки от 7 дней до 1 года, ремиссия **от 1 месяца**; хроническая — **более 1 года** без ремиссий или с ремиссией менее 1 месяца
4. **SUNCT и SUNA** — эпизодические — атаки от 7 дней до 1 года, ремиссия **3 месяца и более**; хронические — более 1 года без ремиссии или с ремиссией менее 3 месяцев
5. **гемикрания континуа** — ремиттирующая (ремиссия не менее 1 дня без лечения) и неремиттирующая

Нейропатия лицевого нерва: идиопатическая (G51.0) и симптоматическая (G51.1, G51.2, G51.8, G51.9), поражение отдельных ветвей (G51.8). Гемифациальный спазм — первичный (G51.3) и вторичный. Лицевая миокимия — первичная (G51.4) и вторичная.

Языкоглоточный нерв (ICOP)

1. невралгия: классическая, идиопатическая, вторичная;
2. нейропатическая боль: с установленной причиной, идиопатическая.

2.5 Клиническая картина: тригеминальная невралгия

Диагноз — клинический, по характеру боли

1. приступ **от доли секунды до 2 минут**;
2. высокая интенсивность;
3. боль как электрический разряд, стреляющая, колющая, острая;
4. провокация безболевым воздействием на триггерные точки.

Провоцируют холодный воздух, чистка зубов, умывание, разговор, еда. Чувствительных нарушений нет — кроме симптоматической невралгии.

Персистирующая идиопатическая лицевая боль

1. постоянная тупая ноющая боль, без атак и курковых зон;
2. не соответствует зонам иннервации ветвей тройничного нерва;
3. чаще в области верхней челюсти, распространяется на периорбитальную область, нос, щёку, висок; бывает в одном зубе (атипичная одонталгия);
4. ночью обычно стихает, но у 50–70% нарушен сон;
5. обостряется от холода, стресса, хирургических и стоматологических вмешательств.

Миофасциальная боль со спазмом жевательной мышцы: внезапная боль и ограничение движений челюсти.

Синдром пылающего рта: постоянная жгучая боль на неизменённой слизистой, чаще языка, обычно двусторонняя, к вечеру сильнее; изменение вкуса и сухость во рту при нормальном слюноотделении.

Нейропатическая боль: негативные симптомы (гипестезия, анестезия) и позитивные (гипералгезия, аллодиния, гиперпатия, спонтанная боль, парестезии); аллодиния бывает механическая, температурная, двигательная. Постгерпетическая невралгия — жгучая, колющая боль с парестезией, гипералгезией, зудом, потерей чувствительности и аллодинией.

Нейропатическая боль: симптомы и механизмы

Симптом	Механизм
длительная жгучая боль	нарушение центрального тормозного контроля, центральная сенситизация, эктопические разряды
стреляющая, пронзающая боль	эктопические разряды
парестезия, дизестезия	эктопические разряды, центральная сенситизация
гипералгезия	центральная сенситизация от усиления ноцицептивной афферентации
механическая аллодиния	нарушение центрального торможения, центральная сенситизация, сенситизация ноцицепторов
парадоксальные реакции на температуру	нарушение центрального тормозного контроля
онемение, утрата чувствительности	дегенерация сенсорных волокон, нарушение центрального тормозного контроля

2.6 Клиническая картина: тригеминальные автономные цефалгии

Кластерная головная боль: односторонняя очень сильная боль в области глазницы, подглазничной или височной области, **15–180 минут**, чаще ночью; пациент возбуждён, не находит себе места.

Вегетативные симптомы на стороне боли

1. слезотечение (91%);
2. инъекция конъюнктивы (77%);
3. заложенность носа (75%);
4. птоз, отёк век, миоз;
5. ринорея;
6. потливость и покраснение лица.

Триггеры: алкоголь, вазодилататоры, нарушение сна, перепады давления (авиаперелёт, дайвинг), смена погоды, запахи.

Пароксизмальная гемикрания: сильная боль в области орбиты с вегетативными симптомами по **2–30 минут**, приступы в течение всего дня.

SUNCT и SUNA: короткие (секунды — минуты) приступы боли в области орбиты, часто от прикосновения к коже; при SUNA — чаще в виске, со слезотечением, заложенностью носа, ринореей, без рефрактерного периода (в отличие от тригеминальной невралгии).

Гемикрания континуа: односторонняя боль средней интенсивности с обострениями — в височной, глазничной, лобной, ретроорбитальной или затылочной области.

2.7 Клиническая картина: нейропатия лицевого нерва

Уровень поражения лицевого нерва

Уровень поражения	Симптомы, кроме слабости мимических мышц
мосто-мозжечковый угол	нарушение функции тройничного, отводящего и преддверно-улиткового нервов
внутренний слуховой проход	сухость глаза, нарушение вкуса на передних 2/3 языка, сухость во рту, снижение слуха на стороне поражения, головокружение
костный канал до отхождения большого каменистого нерва	сухость глаза, нарушение вкуса на передних 2/3 языка, сухость во рту, гиперакузия
до отхождения стремянного нерва	слезотечение, нарушение вкуса на передних 2/3 языка, сухость во рту, гиперакузия
выход через шилососцевидное отверстие	только двигательные нарушения и слезотечение
околоушная железа	только двигательные нарушения
отдельные ветви	только двигательные нарушения в зоне иннервации

Диагноз — по осмотру, МРТ и ЭНМГ. Паралич Белла развивается за **24–48 часов**, **максимум за 72 часа**.

Признаки уровня и причины

1. слабость только нижней группы мимических мышц — центральное поражение или поражение отдельных ветвей;
2. гиперакузия, нарушение вкуса, сухость во рту — периферическое поражение выше отхождения стремянного нерва;
3. снижение слуха на стороне поражения нехарактерно: следует заподозрить объёмное образование;
4. боль в ухе или за ухом — симптом идиопатической нейропатии или отогенного процесса;
5. рецидив — у 6,5%; нейропатия в анамнезе ставит идиопатическую форму под сомнение.

«Красные флаги» — нужны дополнительные исследования и консультации

1. симптомы нарастают **более 72 часов**;
2. тяжесть пареза колеблется;
3. слабы только мышцы нижней половины лица;
4. эпизод слабости мышц лица в анамнезе;
5. поражены обе половины лица;
6. снижение слуха;
7. головокружение;
8. другие неврологические симптомы.

У 60–70% пациентов функция восстанавливается полностью или частично **за 3–6 месяцев**, но из-за частых осложнений заболевание считают прогрессирующим и наблюдают. Гипертонус мышц здоровой стороны — **с 7-го дня** у 67%; синкинезии — **с 4 месяцев до года**. Лагофтальм — у 3/4 пациентов, ведёт к ксерозу роговицы, кератиту, язве.

Первичные двигательные нарушения

1. снижение силы и тонуса мышц поражённой стороны;
2. лагофтальм.

Вторичные

1. гипертонус или контрактуры мышц здоровой или поражённой стороны;
2. атрофия мышц поражённой стороны;
3. синкинезии до постпаралитического гемиспазма.

Факторы риска контрактур и синкинезий

1. тяжёлое поражение: прозоплегия, по ЭНМГ поражение нерва **более 90%**;
2. активная стимуляция мышц: ЛФК с максимальной амплитудой движений, электростимуляция.

Изолированное поражение краевой нижнечелюстной ветви (после стоматологических и косметологических вмешательств, операций на голове и шее, травм) — асимметрия улыбки, ошибочно принимаемая за центральное поражение; выявляется пробой «Ы-Ы».

2.8 Клиническая картина: гемифациальный спазм и миокимия

Гемифациальный спазм: спонтанный односторонний клонический и (или) тонический спазм мышц лица, в покое и во сне; бывают щелчки в ухе (сокращение стременной мышцы) и боль как при невралгии тройничного нерва. Обычно начинается с круговой мышцы глаза. Двусторонний — менее 5%.

«Красные флаги» при лицевой миокимии

1. подёргивания и в других мышцах лица или тела;
2. двусторонний процесс;
3. глаз открывается с трудом, опущение века;
4. покраснение или отёк века, боль;
5. не проходит за несколько недель;
6. другие неврологические симптомы.

Непроизвольные движения лица

Состояние	Отличительный признак
Лицевая миокимия	периодические низкоамплитудные сокращения 1–2 мышц, проходят сами, заметнее пациенту
Блефароспазм, лицевой параспазм	длительные прогрессирующие двусторонние скручивающие движения, вовлекаются соседние мышцы
Синкинезии	только при определённом движении: одна мышца провоцирует сокращение другой
Тики	дебют в 3–7 лет, прогрессируют только до подросткового возраста
Эпилепсия с миоклонией век (синдром Дживонса)	миоклония век с абсансами или без, дрожание век с двух сторон сразу после медленного закрытия

2.9 Клиническая картина: другие черепные нервы

1. **Обонятельный** — гипосмия, аносмия, гиперосмия
2. **Глазодвигательные** — птоз, косоглазие, диплопия, изменение ширины зрачка, нарушение конвергенции, аккомодации и сочетанных движений глаз
3. **Языкоглоточный** — невралгия — пароксизмальная боль по типу удара тока в задней части языка, миндалине, глотке, у угла нижней челюсти и (или) в ухе; нейропатия — расстройство вкуса задней трети языка, снижение чувствительности верхней половины глотки; болевая нейропатия — постоянная боль в зоне нерва

1. **Блуждающий** — редко изолированно; парез мышц глотки и голосовых складок — дисфагия, дисфония, дизартрия; тахи- или брадикардия; при двустороннем поражении — нарушение ритма дыхания
2. **Добавочный** — голова отклонена в больную сторону, ограничен поворот в здоровую, затруднено поднимание плеч; позже атрофия грудино-ключично-сосцевидной и трапециевидной мышц
3. **Подъязычный** — парез половины языка, язык отклоняется в сторону поражения; при ядерном поражении — атрофия и фибриллярные подёргивания; двустороннее — глоссоплегия, дизартрия или анартрия

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз тригеминальной невралгии клинический. Нейроваскулярный конфликт на МРТ сам по себе не является основанием для диагноза классической невралгии. Это относится и к невралгии языкоглоточного нерва.

Общепринятых критериев для поражений лицевого нерва нет: диагноз устанавливается на основании жалоб, анамнеза, осмотра и инструментальных данных. Задача обследования — установить уровень поражения, причину, тяжесть и прогноз восстановления.

Поражения обонятельного нерва, нервов глазодвигательной и каудальной групп диагностируют по жалобам и данным неврологического осмотра; необходимо выявить основное заболевание.

Критерии диагноза: атипичная лицевая боль

Форма	Критерии
Персистирующая идиопатическая лицевая боль	ежедневно более 2 часов более 3 месяцев; плохо локализована, не соответствует зоне нерва; тупая, ноющая или тянущая; обследование патологии не выявляет
Миофасциальная боль со спазмом	спазм жевательной мышцы, боль связана со спазмом по времени и динамике; боль в челюсти, виске, ухе или перед ухом, вызывается пальпацией мышцы или открыванием рта
Синдром пылающего рта	ежедневно более 2 часов более 3 месяцев; жжение поверхностно в слизистой; слизистая не изменена, местные и системные причины исключены

Критерии диагноза: тригеминальная нейропатическая боль

Форма	Критерии
Связанная с Herpes zoster	односторонняя боль менее 3 месяцев; высыпания в зоне нерва или VZV в ликворе (ПЦР) или в материале из очагов; бывает без высыпаний (zoster sine herpete)
Постгерпетическая невралгия	боль более 3 месяцев в зоне ветвей, поражённых Herpes zoster, связана с ним по времени

Форма	Критерии
Посттравматическая	боль **более 3 месяцев**, повреждение нерва в анамнезе и по исследованиям, начало **не позднее 6 месяцев** после травмы, соматосенсорные симптомы в той же зоне; часто — после стоматологического лечения
Связанная с другим нарушением	боль 3 месяца и более, есть способное её вызвать расстройство, соматосенсорные симптомы в зоне боли
Идиопатическая	боль 3 месяца и более с соматосенсорными симптомами, поражение нерва есть, травмы и другой причины нет

Критерии диагноза: тригеминальные автономные цефалгии

Форма	Критерии
Кластерная головная боль	не менее 5 атак; сильная односторонняя боль в глазничной, подглазничной и (или) височной области **15–180 минут**; на стороне боли — инъекция конъюнктивы или слезотечение, заложенность носа или ринорея, отёк век, потливость лица, миоз или птоз, и (или) беспокойство; от 1 раза в 2 дня до 8 раз в день
Пароксизмальная гемикрания	не менее 20 атак по **2–30 минут**, более 5 в день, те же вегетативные симптомы, полностью проходит от индометацина
SUNCT	не менее 20 атак **1–600 секунд**, с вегетативными симптомами, не реже раза в день
SUNA	не более одного из симптомов: инъекция конъюнктивы, слезотечение
Гемикрания континуа	односторонняя боль **более 3 месяцев** с обострениями, вегетативные симптомы (в том числе ощущение распирания в ухе), абсолютный эффект индометацина

3.2 Жалобы и анамнез

Нейропатия лицевого нерва

При асимметрии лица вследствие слабости мимических мышц необходим активный сбор жалоб и анамнеза, включая эпидемиологический, для определения уровня поражения (центральный или периферический) и причины.

Уточнить

1. длительность и скорость развития, порядок появления симптомов;
2. слабость верхней и нижней групп мимических мышц;
3. гиперакузию, нарушение вкуса, сухость во рту;
4. боль в ухе или за ухом накануне или в начале асимметрии;
5. травмы, операции, косметологические и стоматологические вмешательства;
6. гипертоническую болезнь, сахарный диабет, неврологические заболевания, беременность;
7. лихорадку, увеличение лимфатических узлов, покраснение или отёк тканей головы и шеи;
8. высыпания на лице, в околоушной области, в ушной раковине;
9. пребывание в регионах клещевого энцефалита **в течение месяца** до начала.

При наличии «красных флагов» показано расширенное клинико-лабораторное и инструментальное обследование.

Лицевая боль

«Красные флаги» при лицевой боли — признаки вторичной природы

1. внезапное начало;
2. лихорадка, сыпь, менингеальные симптомы;
3. боль усиливается при перемене положения, нагрузке, кашле, чихании;
4. нарастающая боль, резистентная к лечению;
5. боль впервые **после 50 лет**;
6. изменения неврологического статуса;
7. необъяснимая потеря веса, гипергидроз;
8. онкологическое заболевание, иммунодефицит, длительный приём глюкокортикоидов.

Диагноз атипичной лицевой боли устанавливается по критериям Международной классификации орофациальной боли.

При боли в зоне ветвей тройничного нерва собирают анамнез и жалобы, оценивают боль и чувствительные нарушения в лице. Нейропатический характер боли подтверждают опросниками DN-4, painDETECT, LANSS.

3.3 Неврологический осмотр

Нейропатия лицевого нерва

Невролог выполняет осмотр с пальпацией околоушных слюнных желёз и лимфатических узлов.

Оценивают силу каждой мимической мышцы, тонус на обеих сторонах, смещение средней линии лица, синкинезии: это позволяет определить уровень и степень поражения.

Тяжесть поражения оценивают по шкале House-Brackmann с записью в медицинскую документацию; для наблюдения в динамике используют более чувствительную шкалу Sunnybrook.

Для ранней профилактики осложнений и направления к офтальмологу оценивают лагофтальм: смыкание век спокойно и с усилием, расстояние между веками в мм, положение век, инъекцию конъюнктивы.

Повторный осмотр невролога в течение нескольких месяцев после начала восстановления необходим для профилактики и лечения осложнений, в том числе глазных.

Проверка мимических мышц

Мышца	Проба
лобное брюшко надчерепной мышцы	поднять брови
мышца, сморщивающая бровь	нахмуриться
круговая мышца глаза, вековая часть	спокойно закрыть глаза
круговая мышца глаза, орбитальная часть	зажмуриться
мышцы, поднимающие верхнюю губу, крыло носа, угол рта	показать «оскал»
малая и большая скуловые	сомкнуть губы и улыбнуться
щёчная	надуть щёки

Мышца	Проба
мышца смеха	широко улыбнуться с разомкнутыми губами
круговая мышца рта	вытянуть губы трубочкой
опускающая угол рта	грустная улыбка
опускающая нижнюю губу	опустить губу, сказать «Ы-Ы»
подбородочная	поднять нижнюю губу
подкожная мышца шеи	сказать «Ы-Ы» и напрячь шею

Патологические синкинезии

Синкинезия	Проявление
оро-окулярная	при вытягивании губ, надувании щёк, жевании сужается глазная щель
окуло-фронтальная	при моргании и зажмуривании морщится лоб
окуло-скуловая	при моргании и зажмуривании углубляется носогубная складка
окуло-назальная	при моргании и зажмуривании сокращается носовая мышца (может быть физиологической)
синкинезия Гюйе	при зажмуривании крыло носа поднимается вверх и кнаружи
окуло-оральная	при моргании и зажмуривании сокращаются носогубная складка, скуловые мышцы, верхняя губа
окуло-платизменная	зажмуривание напрягает подкожную мышцу шеи
окуло-аурикулярная	при зажмуривании поднимается ушная раковина
фронто-назальная	поднимание бровей сокращает носовую мышцу
фронто-оральная	при наморщивании лба сокращается угол рта
синкинезия Марина-Амата	открывание рта или боковые движения челюсти закрывают веки (редко)
«крокодиловы слёзы»	слезотечение на поражённой стороне при жевании
окуло-стапедиальная	при моргании и закрывании глаз — одностороннее снижение слуха или шум в ухе
звукоиндуцированная	звуки (клавиши, хлопки, труба) вызывают сокращение мимических мышц
ретроаурикулярная боль	хроническая боль за ухом во время менструации после паралича Белла

Гемифациальный спазм и лицевая миокимия

При гемифациальном спазме невролог выполняет осмотр с пальпацией околоушных желёз и лимфатических узлов, оценивает все мимические мышцы и непроизвольные движения; возможны прозопарез и гипертонус.

При лицевой миокимии выполняют такой же осмотр для выявления «красных флагов».

Невралгия языкоглоточного нерва

При подозрении на невралгию языкоглоточного нерва неврологический осмотр с пальпацией позволяет исключить вторичную причину.

Тройничный нерв и лицевая боль

При тригеминальной невралгии невролог исследует чувствительность в зонах ветвей тройничного нерва, выполняет бимануальную пальпацию жевательных мышц и провокацию боли с триггерных точек для исключения симптоматической невралгии, дисфункции ВНЧС, миофасциальной боли.

При атипичной лицевой боли оценивают неврологический, соматический и местный статус; при «красных флагах» проводят поиск причин вторичной боли.

Осмотр головы и шеи: повреждения и цвет кожи, отёк; пальпация лимфатических узлов и слюнных желёз. Пальпация мышц лица с усилием **1 кг**: **2 секунды** — местная боль, **5 секунд** — отражённая.

При подозрении на тригеминальную нейропатическую боль исследуют чувствительность в зонах ветвей, корнеальный рефлекс, отмечают депигментацию или пигментацию кожи лица.

При сомнительном диагнозе тригеминальной нейропатической боли бимануальная пальпация жевательных и височных мышц позволяет исключить дисфункцию ВНЧС.

При впервые возникшей боли в зоне глазничной ветви у пациентов **после 50 лет** с эпизодами amaurosis fugax пальпируют поверхностную височную артерию для исключения гигантоклеточного артериита.

При тригеминальных автономных цефалгиях осмотр невролога необходим для исключения вторичного характера головной боли.

3.4 Анализы крови

Нейропатия лицевого нерва

Развёрнутый общий анализ крови: сдвиг лейкоцитарной формулы в сторону нейтрофилов свидетельствует о неблагоприятном прогнозе.

Биохимический анализ крови с определением глюкозы натощак позволяет исключить метаболические причины.

При сахарном диабете определяют гликированный гемоглобин: таким пациентам потребуются высокие дозы глюкокортикоидов.

При подозрении на инфекционную причину в начале заболевания определяют антитела к ВИЧ-1 и ВИЧ-2, вирусу простого герпеса, VZV, цитомегаловирусу, вирусу Эпштейна — Барр, вирусу герпеса 6 типа.

При подозрении на клещевой энцефалит определяют антитела к вирусу клещевого энцефалита.

Определяют уровень ТТГ: при гипотиреозе риск нейропатии лицевого нерва выше.

Гемифациальный спазм и лицевая миокимия

При гемифациальном спазме для исключения вторичных форм выполняют общий и биохимический анализ крови с определением глюкозы.

При лицевой миокимии анализы крови показаны только при наличии «красных флагов».

Тройничный нерв и лицевая боль

Синдром пылающего рта: анализы крови

1. общий и биохимический с глюкозой;
2. витамин B12, фолиевая кислота;
3. гемоглобин, железо, ферритин, трансферрин;
4. эстрадиол, эстрон, эстриол, прогестерон.

Дефицит питания, диабет, климактерические нарушения указывают на вторичный синдром.

Не рекомендуется определять антитела к VZV для подтверждения постгерпетической невралгии: они слишком распространены в популяции.

При боли в зоне глазничной ветви у пациентов **старше 50 лет** с amaurosis fugax определяют СРБ и СОЭ; значимыми считаются СОЭ **≥ 50 мм/ч** или СРБ **≥ 10 мг/л**.

3.5 Магнитно-резонансная томография

Нейропатия лицевого нерва

При сочетании с другими неврологическими симптомами для исключения инсульта экстренно выполняют КТ или МРТ. При типичной картине экстренная МРТ не требуется.

Показания

1. симптомы сохраняются **более 3 недель**;
2. «красные флаги».

Выполняют МРТ головного мозга с контрастным усилением по расширенному протоколу, по возможности с захватом околоушной железы. При невозможности МРТ выполняется КТ с контрастным усилением.

Исследование позволяет исключить

1. объёмное образование;
2. воспаление, демиелинизацию;
3. инсульт;
4. нейроваскулярный конфликт.

При типичной картине объёмное образование находят в **8–12%**, из них 30% злокачественные. У 80% выздоравливающих восстановление начинается **в первые 2–3 недели**.

При тяжёлом поражении, сохраняющемся **более 3 месяцев**, и подозрении на атрофию выполняют МРТ мягких тканей лица, прежде всего скуловых мышц: при тотальном поражении атрофия развивается быстро, и позднее хирургическое лечение может оказаться нецелесообразным.

Невралгия языкоглоточного нерва

Всем пациентам показана МРТ головного мозга с захватом краниовертебрального перехода в режиме 3D SPGR. После исключения вторичных причин выполняют режимы FIESTA и 3D TOF для подтверждения классической невралгии.

Гемифациальный спазм и лицевая миокимия

Всем пациентам с гемифациальным спазмом показана МРТ по расширенному протоколу (3D-T2, 3D-TOF, FIESTA и др.) для выявления нейроваскулярного конфликта.

Если на бесконтрастных сериях конфликт не выявлен, выполняют МРТ с контрастным усилением для исключения опухоли и других причин.

При лицевой миокимии с «красными флагами» показана МРТ с контрастным усилением; без них МРТ **не рекомендуется**.

Тройничный нерв, лицевая боль и тригеминальные автономные цефалгии

При тригеминальной невралгии всем пациентам показана обзорная МРТ в режиме 3D SPGR для исключения опухоли и демиелинизации; при подозрении на них исследование выполняют с контрастным усилением.

При фармакорезистентности, непереносимости или низкой приверженности лечению МРТ в режимах FIESTA и 3D TOF позволяет подтвердить или исключить нейроваскулярный конфликт.

Конфликт диагностируют при структурных изменениях корешка (дистопия, атрофия). Толщина среза **0,4–0,6 мм**, аппарат лучше 3 Тл, не менее 1,5 Тл.

При впервые выявленной атипичной лицевой боли с «красными флагами» показана МРТ головного мозга.

При атипичной картине лицевой боли, «красных флагах» и изменениях неврологического статуса выполняют МРТ головного мозга, мягких тканей головы, шейного отдела позвоночника и шеи.

Дифференциальный диагноз: патология костей черепа, болезни уха, синусит, патология челюстей, зубов, ВНЧС, краниальных нервов, тригеминальная и языкоглоточная невралгия, невралгия промежуточного нерва, внутричерепные опухоли и опухоли полости рта и др.

При возможной посттравматической, возможной связанной с другим нарушением и идиопатической тригеминальной нейропатической боли выполняют обзорную МРТ.

При впервые возникших приступах SUNCT или SUNA МРТ позволяет исключить очаговое поражение головного мозга.

При впервые выявленной кластерной головной боли или пароксизмальной гемикрании показана МРТ с контрастным усилением для исключения опухоли, мальформации и воспаления; при гемикрании континуа также выполняют МРТ.

Кластерную головную боль отличают от других цефалгий, мигрени, височного артериита, тригеминальной невралгии, синусита, глаукомы, опухоли, мальформации, инсульта, диссекции артерий.

3.6 КТ височной кости и другие лучевые исследования

Нейропатия лицевого нерва

При подозрении на ЛОР-патологию или травму височной кости показана КТ височной кости; при невозможности КТ выполняется рентгенография височной кости.

Невралгия языкоглоточного нерва

Если МРТ не выявила причину, выполняют КТ краниовертебрального перехода.

Диагностические признаки

1. удлинённый шиловидный отросток;
2. кальцинированная шилоподъязычная связка.

При подозрении на вторичную невралгию или нейропатическую боль языкоглоточного нерва, если МРТ головы причину не выявила, показана МРТ мягких тканей шеи с контрастным усилением и жироподавлением.

Тройничный нерв и лицевая боль

При возможной связанной с другим нарушением и идиопатической тригеминальной нейропатической боли для исключения одонтогенных причин и синусита выполняют ОПТГ, КЛКТ и (или) КТ или рентгенографию околоносовых пазух.

При лицевой боли, не отвечающей критериям тригеминальной невралгии, по клинической картине назначают ОПТГ, КЛКТ, МРТ ВНЧС, УЗИ слюнных желёз, осмотр и пальпацию мышц.

3.7 Видеоларингоскопия

При невралгии языкоглоточного нерва видеоларингоскопия показана всем пациентам для уточнения причины.

3.8 Ультразвуковое исследование

Нейропатия лицевого нерва

При нейропатии неясной причины, сохраняющейся **более 3 недель**, если выполнение МРТ затруднено, показано УЗИ околоушной слюнной железы.

При тяжёлом поражении по данным ЭНМГ, сохраняющемся **более 3 месяцев**, УЗИ мягких тканей лица выявляет атрофию мышц и позволяет своевременно направить пациента к хирургу.

Невралгия языкоглоточного нерва

При невралгии языкоглоточного нерва всем пациентам показано УЗИ слюнных желёз и мягких тканей шеи.

Гемифациальный спазм

При гемифациальном спазме неясной причины выполняют УЗИ околоушной слюнной железы (или МРТ).

3.9 Электронейромиография и электромиография

Нейропатия лицевого нерва

Показания

1. тяжёлая нейропатия (V–VI степень по House-Brackmann).

Стимуляционную ЭНМГ выполняют **не ранее 8 суток**, предпочтительно **на 9–20 день**, с обеих сторон (круговые мышцы глаза и рта).

Диагностические признаки

1. амплитуда М-ответа на поражённой стороне ниже **на 90% и более**: неблагоприятный прогноз, показана игольчатая ЭМГ.

При асимметрии М-ответа более 90% выполняют игольчатую ЭМГ не менее двух мышц верхней и нижней порций. Отсутствие потенциалов двигательных единиц при произвольном сокращении свидетельствует о тотальном поражении, неблагоприятном прогнозе и является показанием к операции.

Отсутствие потенциалов двигательных единиц может не иметь прогностического значения **до 15 дня** — исследование повторяют.

При изолированном поражении ветви выполняют игольчатую ЭМГ плегированной мышцы (например, опускающей нижнюю губу). При травме потенциалы могут появиться только на 4-м месяце.

Если тяжёлая нейропатия сохраняется, игольчатую ЭМГ повторяют **через 6 месяцев** (при отсутствии восстановления и травмы — **через 3 месяца**) для решения вопроса об операции.

При неполном поражении (**менее IV степени**) и сохранённых движениях во всех ветвях ЭНМГ и ЭМГ **не рекомендуются**: прогноз благоприятный.

Тройничный нерв и лицевая боль

При миофасциальной боли со спазмом и недостатке данных выполняют накожную ЭМГ: регистрируются потенциалы двигательных единиц в покое.

При возможной и идиопатической тригеминальной нейропатической боли, если повреждение не подтверждено другими методами, исследуют коротколатентные вызванные потенциалы тройничного нерва.

3.10 Количественное сенсорное тестирование

При персистирующей идиопатической лицевой боли с подозрением на сенсорные нарушения показано количественное сенсорное тестирование.

При тригеминальной нейропатической боли количественное сенсорное тестирование позволяет объективизировать нарушения.

3.11 Консультация оториноларинголога

Показания

1. нейропатия лицевого нерва: всем пациентам осмотр с отоскопией для исключения отогенной причины, по показаниям аудиометрия и тимпанометрия.

Диагностические признаки

1. кондуктивная тугоухость: подозрение на опухоль лицевого нерва в пирамиде височной кости;
2. нейросенсорная тугоухость: подозрение на сдавление нерва объёмным образованием в мосто-мозжечковом углу.

Тимпанометрия оценивает акустический рефлекс стременной мышцы.

При подозрении на лицевую боль, связанную с заболеванием околоносовых пазух (при тригеминальной невралгии и поражениях других черепных нервов), показана консультация оториноларинголога.

3.12 Другие консультации

Нейропатия лицевого нерва

При неосложнённом лагофтальме консультация офтальмолога проводится планово, при **осложнённом** (покраснение, жжение, боль, светобоязнь, дефекты роговицы) — **экстренно**.

При подозрении на инфекционную природу нейропатии показана консультация инфекциониста.

Консультация психолога показана при социальной дезадаптации, неприятии внешности, тревоге, апатии, нарушениях сна; при суицидальных мыслях необходима консультация психиатра.

При тяжёлой нейропатии (V–VI степень) или осложнениях (гипертонус, синкинезии) консультация врача ЛФК обязательна; остальным пациентам достаточно домашней самореабилитации.

Стоматолог и челюстно-лицевой хирург

Консультация стоматолога показана при сомнительном диагнозе тригеминальной невралгии или невралгии языкоглоточного нерва, всем пациентам с синдромом пылающего рта и персистирующей идиопатической лицевой болью, а также при подозрении на одонтогенную нейропатическую боль.

Синдром пылающего рта: слизистая должна быть без изменений; эрозии и язвы, не заживающие **2 недели**, — биопсия.

При подозрении на боль, связанную с травмами и другими заболеваниями челюстно-лицевой области, показана консультация челюстно-лицевого хирурга.

Психиатр и медицинский психолог

Консультация психиатра необходима при тревоге, депрессии и во всех случаях сомнительной тригеминальной невралгии после исключения орофациальной боли.

При синдроме пылающего рта с тревогой, депрессией или болью **более 3 месяцев** пациента направляют к психиатру.

Пациентам с персистирующей идиопатической лицевой болью при тревоге, депрессии или хронической боли также показана консультация психиатра.

Миофасциальная боль со спазмом в сочетании с тревогой, депрессией или хронической болью служит поводом для консультации психиатра.

При тригеминальной нейропатической боли с тревогой и депрессией рекомендована консультация психиатра.

При хронической тригеминальной нейропатической боли медицинский психолог оценивает факторы хронизации.

Нейрохирург

При тригеминальной невралгии с фармакорезистентностью, непереносимостью или низкой приверженностью лечению показана консультация нейрохирурга.

При тригеминальной нейропатической боли с фармакорезистентностью или непереносимостью лечения нейрохирург решает вопрос о пункционных и хирургических методах.

Невралгия языкоглоточного нерва с фармакорезистентностью или непереносимостью лечения также является показанием к консультации нейрохирурга.

Другие специалисты

При подозрении на демиелинизирующее заболевание по данным МРТ показана консультация невролога кабинета рассеянного склероза.

При нейропатической боли, связанной с Herpes zoster, показана консультация дерматовенеролога и (или) инфекциониста, при глазничной локализации — офтальмолога.

При боли в зоне глазничной ветви у пациентов **старше 50 лет** с amaurosis fugax ревматолог исключает гигантоклеточный артериит.

3.13 Направление к хирургу

Нейропатия лицевого нерва

Операция — при неблагоприятных клинических и миографических признаках

1. **до 3 месяцев, идиопатическая форма** — декомпрессия лабиринтного сегмента нерва
2. **до 18 месяцев** — реиннервирующая операция
3. **позже** — реконструктивно-пластическая операция

При идиопатической нейропатии тяжёлой степени консультация нейрохирурга показана как можно раньше, но после ЭНМГ и ЭМГ (**не ранее 8 суток**), для решения вопроса о декомпрессии.

Отбор: V–VI степень, разница М-ответа **более 90%**, рецидивы и другие причины исключены. Декомпрессию предпочтительно делают **в течение 14 дней**, через среднюю черепную ямку; возможна **до 3 месяцев**. Есть положительная динамика — не оперируют.

При тяжёлой нейропатии, сохраняющейся **после 3 месяцев** (идиопатической или симптоматической), показана консультация челюстно-лицевого хирурга для решения вопроса о реиннервирующей (до 18 месяцев) или реконструктивно-пластической операции; учитывают атрофию мышц по данным УЗИ или МРТ.

При постпаралитическом гемиспазме с выраженными синкинезиями челюстно-лицевой хирург решает вопрос о селективной нейрэктомии; при лёгком и умеренном гемиспазме применяют ботулинический токсин и реабилитацию.

Гемифациальный спазм

При первичном гемифациальном спазме с нейроваскулярным конфликтом на МРТ показана консультация нейрохирурга для решения вопроса о васкулярной декомпрессии.

При вторичном гемифациальном спазме с объёмным образованием на МРТ нейрохирург определяет показания к операции.

---

4. Лечение

4.1 Тригеминальная невралгия: подходы

Применяют три подхода: консервативную терапию (профилактическое лечение и купирование приступов), малоинвазивные вмешательства и операции.

Всем пациентам с установленным диагнозом показана профилактическая терапия для урежения приступов. Препаратами первой линии являются карбамазепин и окскарбазепин; остальные препараты относятся ко второй линии и применяются отдельно или вместе с препаратами первой линии.

Правила

1. начинать с монотерапии, препараты добавлять поочерёдно;
2. заменять препарат постепенно, по инструкции;
3. ремиссия — нет боли **не менее 4 недель**: медленно снижать дозу, можно отменить;
4. рецидив — постепенно вернуться к минимальной эффективной дозе;
5. на противоэпилептических препаратах — анализы крови **каждые 3–6 месяцев**: общий, биохимия (глюкоза, ЩФ, АЛТ, АСТ, билирубин), натрий, калий; по показаниям ЭКГ и концентрация препарата;
6. нет эффекта при хорошей переносимости — психиатр;
7. для направления к нейрохирургу не нужно перепробовать все препараты.

Профилактическое лечение тригеминальной невралгии

Препарат	Схема	Доза в сутки	Частые побочные эффекты
карбамазепин	100 мг 2 раза в день, повышать на 100–200 мг каждые 3 дня до 200 мг 4 раза в день	800–1200 мг	седация, головокружение, нечёткость зрения, тошнота, неустойчивость, вялость, диплопия, головная боль; гипонатриемия, кожная сыпь, панцитопения; остеопороз при длительном приёме; снижает эффективность оральных контрацептивов
#окскарбазепин	150 мг 2 раза в день, повышать на 150–300 мг каждые 3 дня до 300 мг 4 раза в день	1200–1800 мг	сонливость, головокружение, диплопия, спутанность сознания, тошнота, боль в животе, головная боль, депрессия, диарея; высокий риск гипонатриемии; остеопороз при регулярном приёме; снижает эффективность оральных контрацептивов
#ламотриджин	25 мг 1 раз в день, повышать на 25 мг каждые 2 недели, после 100 мг — каждую неделю; свыше 100 мг — в 2 приёма	200 мг	нечёткость зрения, возбуждение, агрессия, неустойчивость, головокружение, тошнота, сухость во рту, бессонница, боль в суставах; сыпь и синдром Стивенса — Джонсона при быстром повышении дозы; можно отменять без титрации
#баклофен	5 мг 3 раза в день, повышать на 5 мг каждые 3 дня	40–80 мг	тревога, депрессия, возбуждение, неустойчивость, головная боль, седация, тремор, кожная сыпь, нечёткость зрения, сухость во рту, боль в животе; синдром отмены при слишком быстром прекращении
#габапентин	300 мг 1 раз в день, повышать на 300 мг ежедневно до 900 мг, затем на 300 мг каждые 3–5 дней	900–3600 мг	амнезия, спутанность сознания, головокружение, сонливость, депрессия, тошнота, нечёткость зрения, периферические отёки и отёки лица, запор, вздутие живота, прибавка веса
#прегабалин	75 мг 2 раза в день	600 мг	спутанность сознания, сонливость, запор, нечёткость зрения, головокружение, тошнота, периферические отёки и отёки лица, повышение аппетита, прибавка веса

Каждый из препаратов таблицы рекомендован отдельно; при непереносимости баклофена — можно #клоназепам. Пометка off-label (в КР — знак #) — применение вне инструкции.

Опиоиды для профилактического лечения **не рекомендуются**.

Дополнительно применяют ботулинический токсин типа А: 1,25–5 ЕД внутрикожно в триггерные точки с интервалом 15–20 мм, всего 25–100 ЕД.

Дополнительным методом является высокочастотная ритмическая транскраниальная магнитная стимуляция.

4.2 Тригеминальная невралгия: купирование приступа

Для купирования острой боли используют местные анестетики. Перед блокадой ветви выполняют кожную пробу.

Купирование приступа

Препарат	Применение
#лидокаин	10% спрей — 2 впрыскивания в носовой ход на стороне боли (частое применение повреждает слизистую из-за спирта); 5% гель на триггерную зону; 2% раствор с #эпинефрином 1:80 000 — блокада ветви; внутривенно 1,5–5 мг/кг дольше 1 часа
#ботулинический токсин типа А	50 ЕД в 1,0 мл 0,9% раствора натрия хлорида подкожно в триггерные точки

НПВП при тригеминальной невралгии **не рекомендуются**: при невропатической боли неэффективны. Если НПВП помогают — искать местное воспаление.

4.3 Тригеминальная невралгия: хроническая боль

При хронической боли применяют #амитриптилин.

Альтернативным препаратом является #дулоксетин.

Возможно также назначение #венлафаксина.

Хроническая боль при тригеминальной невралгии

Препарат	Схема	Доза в сутки	Частые побочные эффекты
#амитриптилин	с 5–6,25 мг вечером за полтора часа до сна, повышать на 5–6,25 мг каждые 3–5 дней	12,5–75 мг	седация, сухость во рту, затруднение мочеиспускания, запор, нечёткость зрения, диплопия, повышение внутриглазного давления, нарушение памяти, тремор, аритмия
#дулоксетин	30 мг утром 1–2 недели, затем 60 мг утром	60 мг	головокружение, сонливость или бессонница, сухость во рту, тошнота, запор, потливость, снижение массы тела
#венлафаксин	с 18,75 мг 2 раза в день во время еды, повышать на 18,75 мг каждые несколько дней; после 75 мг — на 37,5 мг	75–225 мг	тошнота, снижение аппетита, запор, снижение массы тела, артериальная гипертензия, головокружение, бессонница, парестезии, тремор, нечёткость зрения, сексуальная дисфункция, потливость, высокая вероятность синдрома отмены

Психотерапия (когнитивно-поведенческая терапия, биологическая обратная связь, релаксация, майндфулнесс) уменьшает тревогу, депрессию и катастрофизацию боли.

4.4 Тригеминальная невралгия: малоинвазивные вмешательства

При классической невралгии в зоне надглазничного нерва и недостаточном эффекте лечения выполняют термическую радиочастотную абляцию надглазничного нерва под контролем КТ или УЗИ после диагностической блокады.

В зоне подглазничного нерва применяют импульсную и (или) термическую радиочастотную абляцию подглазничного нерва под контролем КТ после диагностической блокады.

При идиопатической или симптоматической невралгии, если лечение основного заболевания не помогло или невозможно, выполняют микробаллонную компрессию гассерова узла.

В той же ситуации возможна термическая радиочастотная абляция тройничного нерва.

Альтернативой является глицериновая ризотомия.

4.5 Тригеминальная невралгия: операции

При фармакорезистентности или непереносимости лечения показано нейрохирургическое лечение в специализированном отделении. Операцию в первые 2 года выбирают 25–40% пациентов.

Классическая невралгия

Методом выбора является микроваскулярная декомпрессия корешка (ретросигмоидный доступ), если на МРТ выявлен конфликт со структурными изменениями корешка; у пациентов **старше 75 лет** решение принимается индивидуально.

Если декомпрессия невозможна или пациент от неё отказался, выполняют стереотаксическую радиохирургию корешка (до **90 Гр**, предпочтительно «Гамма-нож»); повторно — **не ранее 1 года**.

При отсутствии эффекта лечения возможна имплантация нейростимулятора после тестовой стимуляции.

Идиопатическая невралгия

Применяют стереотаксическую радиохирургию.

При неэффективности других методов выполняют частичную сенсорную ризотомию.

Другой вариант при неэффективности остальных методов — имплантация нейростимулятора после тестовой стимуляции.

Невралгия при рассеянном склерозе

Применяют стереотаксическую радиохирургию; при её неэффективности выполняют медиальную таламотомию.

При неэффективности других методов возможна частичная сенсорная ризотомия.

При нейроваскулярном конфликте и изменениях корешка выполняют микроваскулярную декомпрессию. Методы равноценны; безопаснее радиохирургия и пункционные вмешательства.

Если другие методы неэффективны, рассматривается имплантация нейростимулятора.

Симптоматическая невралгия

Выполняют операцию по поводу причины (например, удаление опухоли) с декомпрессией корешка.

Если после лечения причины боль не регрессирует, применяют стереотаксическую радиохирургию.

При неэффективности других методов возможна частичная сенсорная ризотомия.

Ещё один вариант при неэффективности остальных методов — имплантация нейростимулятора.

4.6 Атипичная лицевая боль: лекарства

Персистирующая идиопатическая лицевая боль

Препаратом первого выбора является #амитриптилин: 6,25–12,5 мг вечером с повышением на 6,25–12,5 мг каждые 3–14 дней до 10–75 мг.

При противопоказаниях, плохой переносимости или неэффективности трициклических антидепрессантов назначают #венлафаксин: 18,75 мг 2 раза в день во время еды с повышением на 18,75 мг каждые несколько дней до 75 мг.

Если не подошёл и венлафаксин, применяют #флуоксетин 20 мг 1 раз в день.

При неэффективности или непереносимости антидепрессантов используют габапентин (300 мг 1 раз в день с повышением до 900–3600 мг) или прегабалин (75 мг 2 раза в день, до 600 мг).

При недостаточном эффекте лекарственной терапии вводят ботулинический токсин типа А в область боли.

Синдром пылающего рта

Применяют #амитриптилин с минимальной дозы на ночь, в среднем 10–50 мг в сутки.

Эффективен также габапентин.

Назначают #альфа-липоевую (тиоктовую) кислоту 600 мг в сутки; в сочетании с габапентином она эффективнее.

Миофасциальная боль

При миофасциальной боли со спазмом применяют НПВП, предпочтительно внутрь, без комбинирования, **10–14 дней**; учитывают риск осложнений со стороны ЖКТ и сердечно-сосудистой системы.

При хронической миофасциальной боли назначают #амитриптилин с 10 мг на ночь, до 150 мг в сутки.

При неэффективности антидепрессантов применяют #габапентин с 300 мг с повышением на 300 мг каждые 3 дня до 4200 мг.

Возможно введение ботулинического токсина типа А в поражённые мышцы.

4.7 Атипичная лицевая боль: психотерапия и вмешательства

При персистирующей идиопатической лицевой боли применяют когнитивно-поведенческую терапию.

При синдроме пылающего рта показаны когнитивно-поведенческая терапия и психотерапия.

При миофасциальной боли используют биологическую обратную связь для мышечного и психологического расслабления.

Пациентам с миофасциальной болью рекомендована также когнитивно-поведенческая терапия.

При персистирующей идиопатической лицевой боли без эффекта лекарственной терапии выполняют импульсную радиочастотную абляцию крылонёбного узла после положительной блокады (подскуловой доступ).

4.8 Тригеминальная нейропатическая боль

Медикаментозное лечение

Применяют габапентин (300 мг 1 раз в день с повышением до 900–3600 мг) или прегабалин (75 мг 2 раза в день, до 600 мг) отдельно или в комбинации.

#Окскарбазепин назначают с 300 мг с повышением на 300 мг каждые 3 дня до 1800 мг в 2 приёма.

Антидепрессанты применяют отдельно или в комбинации с препаратами других групп; каждый из трёх препаратов таблицы рекомендован и отдельно (А, 1).

Антидепрессанты при нейропатической боли

Препарат	Схема	Доза в сутки
#амитриптилин	с 5–6,25 мг вечером за полтора часа до сна, повышать на 5–6,25 мг каждые 3–5 дней	75 мг
#дулоксетин	30 мг утром 1–2 недели, затем 60 мг утром	60 мг
#венлафаксин	9,375–18,75 мг 2 раза в день, повышать на 9,375–18,75 мг каждые 3–7 дней	75–225 мг

Дополнительная терапия

Дополнительно используют пластырь с 5% #лидокаином или гель с #лидокаином на область боли.

Опиоиды относятся к третьей линии из-за риска зависимости: тапентадол (B, 2), налоксон + оксикодон, трамадол, морфин (A, 1); доза подбирается индивидуально.

Возможно дополнительное назначение #альфа-липоевой (тиоктовой) кислоты 600 мг в сутки.

Применяют психотерапию: когнитивно-поведенческую, биологическую обратную связь, релаксацию, майндфулнесс.

Дополнительно вводят ботулинический токсин типа A в зоне боли.

Ещё один дополнительный метод — ритмическая ТМС 5–20 Гц, 5–10 сеансов, на моторную или дорсолатеральную префронтальную кору.

При постгерпетической невралгии и посттравматической боли гипербарическая оксигенация (не менее 10 сеансов) уменьшает аллодинию и зуд.

Посттравматическая боль после облучения

1. **#альфа-токоферола ацетат** — выше 400 мг в сутки — вместе с ретинолом
2. **#пентоксифиллин** — 400 мг 2 раза в день 4–6 недель

Там же

1. **гипербарическая оксигенация** — не менее 10 сеансов
2. **глюкокортикоиды** — #дексаметазон 8–20 мг в сутки 3–5 дней с постепенной отменой или #преднизолон в эквивалентной дозе

Вмешательства и операции

При неэффективности других методов выполняют имплантацию нейростимулятора прецентральной коры.

При постгерпетической невралгии в зоне надглазничного нерва применяют импульсную или термическую радиочастотную абляцию надглазничного нерва под контролем КТ после диагностической блокады.

При постгерпетической невралгии возможна имплантация системы периферической стимуляции ветвей после тестовой стимуляции.

При посттравматической боли выполняют имплантацию нейростимулятора ветвей тройничного нерва после тестовой стимуляции.

При неэффективности других методов у пациентов с посттравматической болью возможна тригеминальная нуклеотрактотомия; она сопряжена с риском неврологических осложнений.

4.9 Кластерная головная боль

Купирование приступа

Ингаляция 100% кислорода через маску (лучше с клапаном) **12 л/мин**, иногда 15 л/мин, в течение **20 минут**.

Применяют триптаны; предпочтительно золмитриптан 5–10 мг интраназально в противоположную ноздрю.

Спрей #лидокаина: 4 дозы в ноздрю на стороне боли в положении полулёжа под 45°, голова повёрнута **на 30–40°** в сторону боли; действует около 2 часов.

Трансназальная блокада крылонёбного ганглия: тампон с 10% #лидокаином в носовой ход; эффект **через 30–40 минут**, продолжительность **не менее 5 часов**.

Профилактическое лечение

Препаратом профилактики является #верапамил.

1. начальная доза: **240 мг** в сутки, повышение на 80 мг каждые 3–4 дня;
2. ЭКГ: до начала лечения и после 480 мг на каждые 160 мг;
3. до 960 мг: под наблюдением кардиолога.

На время подбора верапамила или при эпизодической форме **до 8 недель** назначают #преднизолон 100 мг утром 5 дней с последующим снижением на 20 мг каждые 3 дня.

#Лития карбонат 353–900 мг; целевой уровень лития 0,6–0,8 ммоль/л (не выше 1,2), контролируют электролиты, функцию почек, ТТГ, анализ крови, ЭКГ.

Возможно назначение #мелатонина 10 мг.

Применяют также #топирамат с титрацией до 50–100 мг.

При тяжёлом течении до подбора лечения выполняют блокады большого затылочного нерва анестетиком с глюкокортикоидом или без него; эффект сохраняется 2–4 недели.

Фармакорезистентные формы

При фармакорезистентной эпизодической форме выполняют радиочастотную абляцию крылонёбного ганглия.

При фармакорезистентной хронической форме абляцию крылонёбного ганглия выполняют после положительной блокады.

Для хронической фармакорезистентной формы применяют также стимуляцию затылочных нервов.

Ещё один вариант при хронической фармакорезистентной форме — стимуляция крылонёбного ганглия.

4.10 Другие тригеминальные автономные цефалгии

Пароксизмальная гемикрания

При пароксизмальной гемикрании назначают #индометацин до 250 мг в сутки.

SUNCT и SUNA

При SUNCT применяют #ламотриджин с 50 мг в сутки (при SUNA он менее эффективен).

Другой вариант при SUNCT — #габапентин с 300 мг с повышением на 300 мг каждые 3 дня до 4200 мг.

При SUNA используют другие противоэпилептические средства.

При обострении SUNCT на время подбора лечения вводят #лидокаин внутривенно.

Гемикрания континуа

При гемикрании континуа назначают #индометацин 25 мг 3 раза в день 5–7 дней; при отсутствии эффекта — 50 мг, затем 75 мг 3 раза в день 2 недели.

4.11 Паралич Белла: лекарства

Глюкокортикоиды назначают **как можно раньше, лучше в первые 72 часа**, при любой тяжести: частота полного восстановления выше на 17%.

Дозы

1. #преднизолон внутрь **60 мг** 5 дней, затем снижать на 10 мг в сутки 5 дней;
2. или **1 мг/кг** 7–10 дней; при V–VI степени без противопоказаний — до **2 мг/кг** в сутки 10 дней;
3. всю дозу утром в 6:00–8:00 после еды или в 2 приёма в первой половине дня;
4. начало лечения **до 3 дней** и тяжесть выше IV степени — лучше однократно #метилпреднизолон **500 мг** внутривенно.

Интратимпанальное введение глюкокортикоидов **до 10 дней** вместе с системной терапией может улучшить исход, но данных пока недостаточно.

Противовирусные средства применяют только вместе с глюкокортикоидами (в монотерапии они неэффективны), на ранней стадии при тяжёлой нейропатии и (или) подтверждённой вирусной инфекции: ацикловир 800 мг 5 раз в сутки или валацикловир 1000 мг 3 раза в сутки.

При синдроме Рамсея Ханта рано назначают глюкокортикоиды (#преднизолон или #метилпреднизолон) вместе с противовирусными средствами, **курс 7 дней**.

При подозрении на болезнь Лайма рано назначают антибиотики: доксициклин, амоксициллин или цефуроксим по инструкции.

При боли в мышцах применяют НПВП, предпочтительно ибупрофен.

Назначают комплекс витаминов группы В.

При неосложнённом лагофтальме невролог незамедлительно назначает увлажнение: днём искусственная слеза, на ночь декспантенол (гель); закапывание — до нескольких раз в день и ночью.

4.12 Нейропатия лицевого нерва: ботулинотерапия

В остром периоде — в мышцы здоровой стороны при гипертонусе или высоком риске его (смещение средней линии ухудшает восстановление); в хроническом — в поражённую сторону при синкинезиях и в здоровую для симметрии. Интервал в среднем 5 месяцев; эффективнее вместе с реабилитацией. Побочно: гематома, избыточная слабость мышцы или соседних мышц (диплопия, нарушение речи).

При умеренном и выраженном гипертонусе мышц здоровой стороны вводят ботулинический токсин типа А в мышцы здоровой стороны, всего **до 50 ЕД**, в сочетании с ЛФК.

При гипертонусе поражённой стороны инъекции выполняют с двух сторон, всего **до 100 ЕД**, в сочетании с ЛФК.

При умеренном и выраженном постпаралитическом гемиспазме инъекции также выполняют с двух сторон, **до 100 ЕД**, в сочетании с ЛФК.

При поражении краевой нижнечелюстной ветви препарат вводят в мышцу, опускающую нижнюю губу, на здоровой стороне: 5 ЕД в одну точку или по 2 ЕД в 2 точки.

4.13 Нейропатия лицевого нерва: операции

Метод выбирают по сроку, уровню, причине и тяжести поражения.

1. **патогенетическое лечение идиопатической формы** — декомпрессия нерва в канале височной кости — только при V–VI степени и разнице М-ответа более 90% с отсутствием потенциалов двигательных единиц
2. **симптоматическое лечение при любой форме** — реиннервирующая операция (**до 2 лет**, оптимально **до 18 месяцев**) или реконструктивно-пластическая; реиннервация — если нет динамики **6 месяцев**

Симптоматическое хирургическое лечение

Пациенты	Операция	Цель
тяжёлая нейропатия до 18 месяцев	реиннервирующие операции	восстановить функцию собственных мимических мышц
тяжёлая нейропатия более 18 месяцев	реконструктивно-пластические (аутотрансплантация мышцы)	заместить атрофированные мышцы
постпаралитический гемиспазм	селективная невротомия, нейрорафия, невролиз	естественная улыбка за счёт разобщения движений
лагофтальм	нейропластические, динамические и статические методы	восстановить или имитировать функцию круговой мышцы глаза

При параличе Белла тяжёлой степени выполняют невролиз и декомпрессию лабиринтного сегмента лицевого нерва.

Сроки

1. лучше **в первые 14 дней**, через среднюю черепную ямку;
2. возможно **до 3 месяцев**;
3. при положительной динамике не оперируют.

Перед декомпрессией выполняют КТ височной кости: ориентиры пирамиды, планирование доступа.

Перед декомпрессией обязательна тональная аудиометрия: риск потери слуха на стороне операции составляет **2–5%**.

При тяжёлой нейропатии **после 3 месяцев и до 2 лет** (лучше до 18 месяцев) показана реиннервирующая операция (нейрорафия).

При тяжёлой нейропатии **более 2 лет** выполняют реконструктивно-пластическую операцию: свободную пересадку или перемещение мышц.

При выраженном постпаралитическом гемиспазме применяют невролиз, нейрорафию, невротомию или миотомию; из-за риска слабости мышц требуется тщательный отбор пациентов.

1. **интракраниальное повреждение до 2 лет** — нейрорафия XII–VII «бок в конец» со вставкой из большого ушного нерва или «конец в конец» с челюстно-подъязычной или жевательной ветвью (С, 4)
2. **нет симметричных синхронных движений** — нейрорафия XII–VII «конец в конец» с икроножным нервом, в том числе по типу мионевротизации (С, 4)
3. **экстракраниальное повреждение с сохранением ствола и ветвей до 2 лет** — нейрорафия XII–VII «бок в конец» с большим ушным нервом, «конец в конец» с жевательной ветвью или анастомоз V–VII с челюстно-подъязычной ветвью (в КР — «СВ», 4)

1. **экстракраниальное без сохранения ствола и ветвей до 2 лет** — ревизия со вставками из большого ушного и (или) икроножного нерва или нейрорафия XII–VII, V–VII со вставками (С, 4)
2. **интракраниальное более 2 лет с атрофией** — пересадка или перемещение мышц с реиннервацией жевательной ветвью и кросс-пластикой (С, 4); если невозможно — статическая коррекция фасцией (С, 4) или нитями

1. **интракраниальное повреждение** — нейрорафии XII–VII «бок в бок», V–VII «конец в бок», VII–VII «конец в бок» с икроножным нервом или с мионевротизацией (С, 4)
2. **экстракраниальное повреждение** — ревизия ствола и ветвей, нейрорафии, вставки, кросс-пластика (С, 4)

1. **контрактуры здоровой стороны** — селективная миотомия или нейротомия на здоровой стороне с мониторингом нерва, нейрорафия VII–VII (C, 4)
2. **контрактуры и синкинезии поражённой стороны** — нейрорафия VII–VII, селективная нейротомия, миотомия (C, 4)
3. **птоз тканей** — статическая коррекция фасцией или круговая подтяжка лица (C, 4)

При паралитическом лагофтальме **более 2 лет** устраняют ретракцию верхнего века и лагофтальм: золотой грузик в верхнее веко, кожно-хрящевой лоскут с ушной раковины, кантопексия, блефарорафия.

4.14 Гемифациальный спазм

Лечением первой линии является ботулинический токсин типа А с двух сторон, всего до 100 ЕД, предпочтительно на ранних этапах.

Мишени

1. круговая мышца глаза;
2. щёчная мышца;
3. подкожная мышца шеи.

Улучшение у 76–100% в течение 7 дней, эффект **до 90 дней**, интервал **от 3 месяцев**.

При возврате спазма после васкулярной декомпрессии также применяют ботулинический токсин, до 100 ЕД.

Нет показаний к операции, противопоказания, отказ или неэффективна ботулинотерапия — препараты

1. #карбамазепин 400–1200 мг в сутки;
2. #габапентин 600–1200 мг;
3. #клоназепам 0,5–4 мг, #диазепам и #лоразепам — в эквивалентных дозах;
4. #баклофен 15–80 мг;
5. #леветирацетам 500–1500 мг;
6. #зонисамид 150 мг 2 раза в сутки 6 недель.

Эффективность не доказана, частая седация и утомляемость.

При первичном спазме с нейроваскулярным конфликтом на МРТ выполняют микроваскулярную декомпрессию корешка лицевого нерва; излечение в течение года **более 90%**.

Во время декомпрессии проводится интраоперационный мониторинг Lateral Spread Recording.

Если операция не показана, противопоказана, пациент отказался или другие методы неэффективны, выполняют радиохирургию лицевого нерва перед внутренним слуховым отверстием: 8 Гр однократно или 15 Гр за 5 фракций.

4.15 Лицевая миокимия

При первичной миокимии рекомендуются покой, ограничение кофеина, устранение провоцирующих факторов (курение, алкоголь); миокимия проходит за несколько дней или недель. При вторичной миокимии лечат причину.

Если миокимия сохраняется **более 3 месяцев**, сначала исключают другие причины, затем вводят ботулинический токсин 5–20 ЕД в мышцу с гиперкинезом.

4.16 Невралгия языкоглоточного нерва

Как и при тригеминальной невралгии, применяют консервативный, малоинвазивный и хирургический подходы. Лечение начинают с монотерапии, препараты добавляют поочерёдно.

Медикаментозное лечение

#Карбамазепин назначают по правилам дозирования при тригеминальной невралгии, 100–2000 мг в сутки.

#Окскарбазепин начинают с 300 мг и постепенно повышают до 1200 мг в сутки.

#Габапентин дозируют по правилам при тригеминальной невралгии, 100–5000 мг в сутки.

Дополнительно вводят ботулинический токсин типа А по 1,25–5 ЕД внутрикожно в перикраниальные мышцы и мышцы шеи, всего 25–100 ЕД.

Малоинвазивные вмешательства

Выполняют импульсную радиочастотную абляцию языкоглоточного нерва под контролем КТ или УЗИ.

Применяют блокаду языкоглоточного нерва в проекции шиловидного отростка под контролем КТ или УЗИ.

Хирургическое лечение

При фармакорезистентной первичной невралгии выполняют микроваскулярную декомпрессию корешка в нейрохирургическом центре.

Если декомпрессия невозможна или пациент отказался, применяют радиохирургию корешка (предпочтительно «Гамма-нож»).

При невозможности декомпрессии возможна частичная сенсорная ризотомия.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Реабилитация при нейропатии лицевого нерва

Медицинская реабилитация в остром и хроническом периоде: массаж лица, растяжение и расслабление, укрепление мышц лица и шеи, нервно-мышечное переобучение, биологическая обратная связь.

Тяжёлая нейропатия (V–VI степень): лечение положением (пластырь, кинезиотейп), массаж, пассивные упражнения. Лёгкая и умеренная (до IV степени): массаж, активные упражнения с дозированной симметричной нагрузкой. Пациенту объясняют: **избегать тепла, «грубого» массажа, электростимуляции, активной мимики** и упражнений с максимальной амплитудой.

Тяжёлая нейропатия — кинезиотейп на поражённую сторону: не дать мышцам перерастянуться, восстановить симметрию.

Тяжёлая нейропатия — пассивные упражнения; умеренная и лёгкая (IV степень и меньше) — активные с дозированным сокращением. **Активная ЛФК при тяжёлой нейропатии не рекомендуется**: здоровая сторона берёт гиперфункцию и смещает среднюю линию.

Комплекс упражнений для самостоятельного выполнения.

Биологическая обратная связь — зеркало (или миография).

Гипертонус здоровой стороны или риск его в остром периоде — упражнения на растяжение и расслабление мышц здоровой стороны.

Гипертонус и (или) синкинезии на поражённой стороне — растяжение и расслабление с двух сторон; синкинезии появляются **с 3-го месяца**.

Контроль домашней самореабилитации; обучение — на первичном приёме невролога.

Неосложнённый лагофтальм — днём пластырь или кинезиотейп на верхнее веко, подтягивание нижнего века при эктропионе; на ночь окклюзия глаза при несмыкании **более 4 мм**.

Неосложнённый лагофтальм — упражнения для баланса круговой мышцы глаза и леватора верхнего века.

Изолированное поражение краевой нижнечелюстной ветви — упражнения для мышцы, опускающей нижнюю губу, 2–3 раза в день перед зеркалом; при благоприятном прогнозе симметрия за 4–5 месяцев.

Дополнительно к стандартному лечению — иглорефлексотерапия, эффективнее в остром периоде.

Форсированные упражнения **не рекомендуются**: укорачивают мышечные волокна, повышают риск синкинезий.

Электростимуляция мышц **не рекомендуется**: по тем же причинам.

Гипербарическая оксигенация.

Лазерная физиотерапия (низко- и высокоинтенсивная) челюстно-лицевой области.

5.2 Диспансерное наблюдение

Сохраняются симптомы нейропатии лицевого нерва или гемифациального спазма — наблюдение невролога.

Сохраняется лицевая миокимия — наблюдение невролога.

5.3 Показания к госпитализации

Нейропатия лицевого нерва — экстренно

1. первые **72 часа** — для внутривенного #метилпреднизолона в высокой дозе;
2. другие неврологические симптомы: слабость или онемение конечностей, головокружение, нарушение глотания;
3. ухудшение с нарушением сознания, лихорадкой, менингеальными симптомами;
4. декомпенсация давления или сахара, беременность.

Планово

1. операция.

Выписка

1. диагноз установлен;
2. состояние стабилизировано.

Тригеминальная невралгия — экстренно

1. впервые сильная боль в зоне глазничной ветви с вегетативными симптомами (отёк век, гиперемия склеры, потливость лба, изменение зрачка, слезотечение, ринорея или заложенность носа) — исключить патологию кавернозного синуса;
2. другие очаговые неврологические симптомы;
3. некупируемая боль.

Планово

1. малоинвазивные вмешательства и операции.

Выписка

1. диагноз установлен, боль уменьшилась, состояние стабильно.

Атипичная лицевая боль и автономные цефалгии — экстренно

1. нарушение сознания;
2. лихорадка и менингеальные симптомы;
3. нарастающая очаговая или общемозговая симптоматика;
4. некупируемая кластерная головная боль — для ингаляций кислорода.

Планово

1. нарастающая боль;
2. резистентная боль — ботулинотерапия или вмешательства (возможно в дневном стационаре).

Выписка

1. снижение интенсивности боли.

Тригеминальная нейропатическая боль — экстренно

1. подозрение на связь с Herpes zoster у пожилых, при иммунодефиците и онкологических заболеваниях.

Планово

1. вмешательства и операции.

Гемифациальный спазм, лицевая миокимия и другие черепные нервы

1. **гемифациальный спазм** — планово — для операции
2. **лицевая миокимия** — амбулаторно
3. **другие черепные нервы** — экстренных показаний нет; планово — для вмешательств и операций

5.4 Исход

Полное восстановление — от 61% при тотальной прозоплегии до 94% при более лёгком парезе.

Осмотр не всегда отражает истинную тяжесть: при V–VI степени ЭНМГ обязательна; асимметрия М-ответа более 90% хотя бы по одной ветви — неблагоприятный прогноз. Гипертонус здоровой стороны — у 68,5% в первые 3 месяца, он ограничивает восстановление.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Краниальные мононейропатии у взрослых»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 26.12.2024
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее декабря 2027 года
Код в рубрикаторе	895_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Ассоциация нейрохирургов России; Всероссийское общество неврологов; Союз реабилитологов России; Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии; Ассоциация специалистов по клинической нейрофизиологии; Ассоциация интервенционного лечения боли
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Сроки реконструктивно-пластической операции при нейропатии лицевого нерва расходятся: в таблице 21 и разделе 2.5 — после 18 месяцев, в рекомендации раздела 3.2.1 — после 2 лет.
- Гемифациальный спазм в разделе 1.5 назван «первичный (симптоматический)», а в разделе 1.2 первичный спазм — от сдавления сосудом, симптоматический — вторичный.

- В разделе 2.3 рекомендация об анализах при гемифациальном спазме адресована «всем пациентам с НЛН»; в разделе 2.5.3 (другие черепные нервы) рекомендации о психиатре и нейрохирурге говорят о тригеминальной невралгии.
- У одной рекомендации о реиннервирующей операции (раздел 3.2.1) уровень убедительности указан как «СВ».
- Код G52.2 (поражения блуждающего нерва) есть в каталоге рубрикатора, но не в разделе 1.4 КР.